

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Pediátrica —

PACIENTE

Valentina Restrepo Gómez

DOCUMENTO

TI 1121000002

FECHA NACIMIENTO

22/08/2015

EDAD

10 años, 9 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

5° Primaria

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

05/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001235

PROTOCOLO APLICADO

WISC-IV + ENI-2 Evaluación Lectoescritura

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Valentina Restrepo Gómez	Lateralidad:	Diestra
Documento:	TI 1121000002	Ocupación:	Estudiante
Fecha de nacimiento:	22/08/2015	Ciudad:	Medellín, Antioquia
Edad:	10 años, 9 meses	Acompañante:	Carlos Mario Restrepo Vélez
Sexo:	Femenino	Remite:	Psicopedagoga colegio
Escolaridad:	5° Primaria	EPS / Asegurador:	Sura EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Dificultad persistente en lectoescritura a pesar de intervención pedagógica. Inversión de letras, omisiones, lectura lenta y con esfuerzo. CI estimado normal por antecedentes académicos.

HISTORIA DEL DESARROLLO

Hitos relevantes en la trayectoria evolutiva

Perinatales y prenatales

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Trayectoria escolar

Estudios: 5° Primaria. Ocupación: Estudiante.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WISC-IV + ENI-2 Evaluación Lectoescritura

Prueba	Dominio	Dur.
Diseño con Cubos	Razonamiento Perceptual	—
Semejanzas	Comprensión Verbal	—
Vocabulario	Comprensión Verbal	—
Claves	Velocidad de Proceso	—
Búsqueda de símbolos	Velocidad de Proceso	—
Regresión Dígitos Directos	Memoria de Trabajo	—
Ind Comp Verb	Índice CI	—
Ind Raz Perce	Índice CI	—
Ind Mem Trab	Índice CI	—
Ind Vel Proce	Índice CI	—
CI total	Inteligencia General	—
Comprensión lectora silenciosa	Lenguaje	—
Comprensión lectora en voz alta	Lenguaje	—
% de palabras con error en la copia	Lenguaje	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Adecuada. No se observan dificultades atencionales clínicamente significativas.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

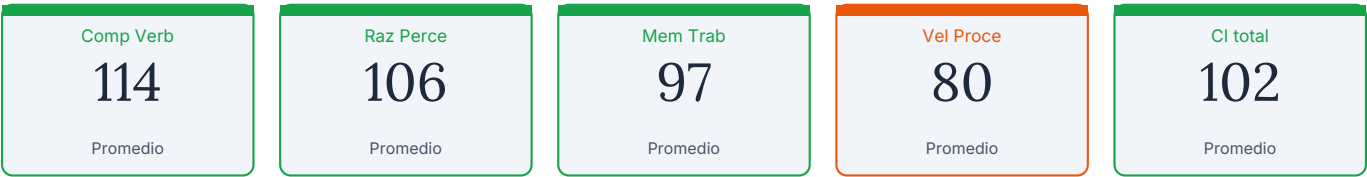
Vocabulario expresivo y comprensivo conservado. Buena discriminación fonológica en tareas aisladas. Dificultad en automatización del proceso lector.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: F81.0 - Trastorno específico de la lectura (dislexia)

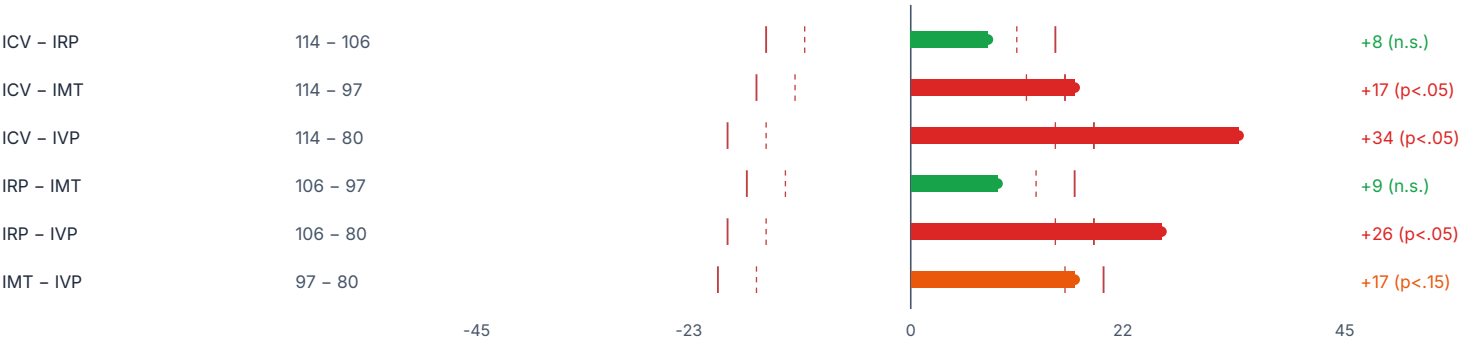
RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

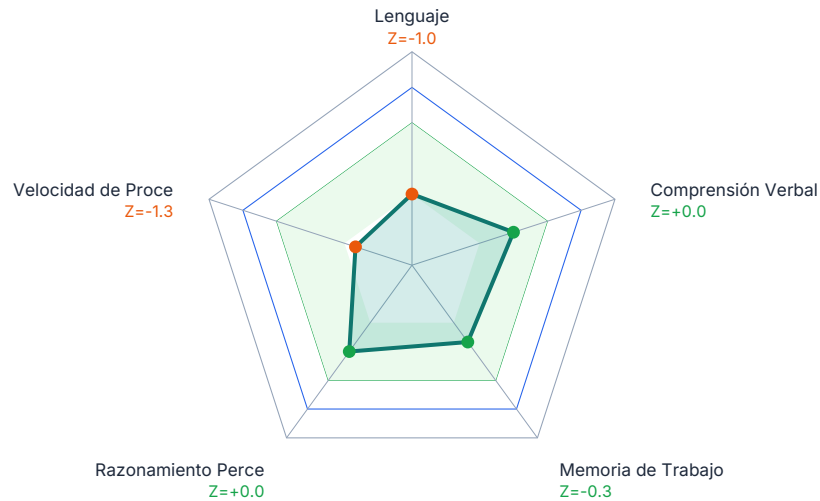


Discrepancias entre índices

Diferencia = valor del primer índice – segundo. Líneas críticas según Wechsler ($p < .15$... y $p < .05$).

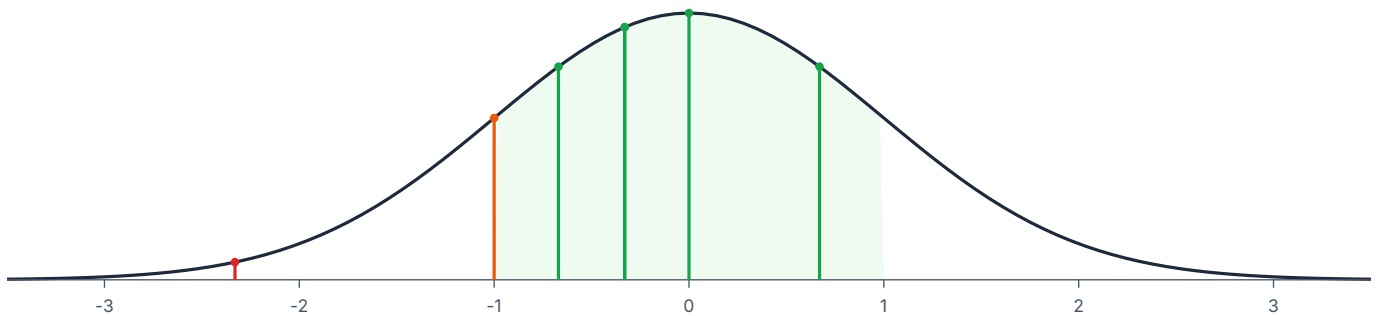


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 7 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Diseño con Cubos							+0.00
Semejanzas							+0.67
Vocabulario							-0.67
Claves							-2.33
Búsqueda de símbolos							-0.33
Regresión Dígitos Directos							-0.33
Ind Comp Verb							+0.93
Ind Raz Perce							+0.40
Ind Mem Trab							-0.20
Ind Vel Proce							-1.33
CI total							+0.13
% de palabras con error en la co							-1.00

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). $Z < -1$ sugiere debilidad. $Z > +1$ sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	32	10	+0.00	Promedio
Semejanzas	26	12	+0.67	Promedio
Vocabulario	28	8	-0.67	Promedio
Claves	24	3	-2.33	Bajo
Búsqueda de símbolos	22	9	-0.33	Promedio
Regresión Dígitos Directos	14	9	-0.33	Promedio
Ind Comp Verb	38	114	+0.93	Promedio
Ind Raz Perce	33	106	+0.40	Promedio
Ind Mem Trab	19	97	-0.20	Promedio
Ind Vel Proce	13	80	-1.33	Promedio
CI total	103	102	+0.13	Promedio
Comprensión lectora silenciosa	16	—	—	Sin dato
Comprensión lectora en voz alta	12	—	—	Sin dato
% de palabras con error en la copi	18	7	-1.00	Promedio

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Valentina obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 102, ubicándose en la categoría promedio (percentil aproximado 55). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IVP (80) y el más alto a ICV (114), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (moderadamente disminuido, $Z=-1.3$); lenguaje (moderadamente disminuido, $Z=-1.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Claves ($Z=-2.33$, bajo); % de palabras con error en la copia ($Z=-1.00$, promedio). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Claves — bajo ($Z=-2.33$)
- % de palabras con error en la copia — promedio ($Z=-1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Valentina. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En NiWiscDC, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En NiWiscSem, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En NiWiscVoc, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En NiWiscCI, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En NiWiscDC, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscSem, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscVoc, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscBusSim, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscRDD, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscCI, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F81

Impresión diagnóstica: F81.0 - Trastorno específico de la lectura (dislexia)

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.